

# Cours d'Habileté Cliniques et Techniques (HCT)

22.09.2021 – Ophtalmologie

## Anamnèse ophtalmologique

- » ATCD spécifiques : lunettes, lentilles (et raison) traumatisme, opération, amblyopie (défaut de développement d'un des deux yeux, par exemple sur très forte myopie infantile)
- » ATCD généraux : diabète, HTA, chirurgie
- » ATCD familiaux : glaucome ou autre, habitudes de vie, traitements (topique ou systémique)
- » Plainte : latéralité, début, évolution, intensité, facteurs aggravants / améliorant la situation, symptômes associés (avec un accent sur le neurologique)

## Examen clinique

- 1) **Inspection** : soulever la paupière supérieure et demander au patient de regarder en bas puis faire l'inverse. Inspecter la conjonctive bulbaire puis palpébrale en soulevant les paupières supérieure puis inférieure. Au coin supéro-externe, observer la zone de la glande lacrymale. Exclure un strabisme notamment en regardant le reflet (atténuation dans la fovéa)
- 2) **Palpation** : cadre osseux oculaire (en cas de traumatisme surtout) **!/\** AD radiologie si douleur à la palpation et hypoesthésie du V2 car possible fracture du plancher de l'orbite). Ensuite, avec les yeux fermés, palper à l'aide des 2 index l'orbite en comparant G/D pour exclure un glaucome
- 3) **Eversion** : en cas de corps étranger ou pour observer en détail la conjonctive palpébrale, éverser la paupière supérieure : appuyer avec un coton tige sur le haut du globe, tirer sur les cils supérieurs et retrousser vivement la paupière par-dessus le coton-tige
- 4) **Examen oculo-moteur (EOM)** : utiliser un stylo ou une lampe mais pas le doigt, pour être précis
  - # Fixation du regard, doit être stable sur 10-15 secondes
  - # Mouvements de poursuite dans les 2 axes. Rechercher un nystagmus en bout de course. Pour les mouvements vers le bas, tenir la paupière supérieure ouverte
  - # Mouvements de saccades dans les 2 axes. Alternier nez-doigt, un œil après l'autre
  - # Convergence en forçant le suivi du regard en faisant des  $\approx$  de plus en plus proche
- 5) **Champs visuels par confrontation** : confrontation = on compare notre champ à celui du patient. Il faut donc que le patient cache un œil et que le médecin fasse miroir. Contrôler les 4 cadrans d'abord en comptant les doigts (une main après l'autre puis en simultané) puis les mouvement d'un doigt en partant depuis derrière le champ de vision, nécessitant de se rapprocher du patient
- 6) **Pupilles** : commencer par une inspection en recherchant une anisocorie. Faire varier la lumière pour déterminer l'œil pathologique. Ensuite, évaluer les réflexes:
  - # Réflexe de convergence : doit créer un myosis bilatéral, fait intervenir la paire III
  - # Réflexe photomoteur : ipsilatéral ET consensuel, puis rechercher un RAPD (Relative Afferent Pupillary Defect) indiquant une neuropathie de la paire II
- 7) **Acuité visuelle** : de près à l'aide de cartes (attention à la distance) et de loin avec des panneaux. Une acuité de 0.8 définit une perte de 20% d'acuité. En l'absence de matériel, lire une petite notice d'un produit par exemple, en cherchant juste une différence G/D et sans forcément quantifier
- 8) **Couleur** : à l'aide des tests de confusion (test d'Ishihara), œil par œil pour faire la distinction entre un daltonisme (bilatéral) et une neuropathie optique (unilatérale). En cas de suspicion d'une neuropathie du II, réaliser un test de saturation au rouge en demandant au patient s'il voit une différence de rouge entre un œil et l'autre (orange / bordeaux si pathologique)

- 9) **Ophthalmoscope** : commencer dans le cadran temporo supérieur et se rapprocher jusqu'à 3-4cm de l'œil. Incliner l'ophtalmoscope par la suite pour observer la rétine au complet.

En pédiatrie, éclairer les deux yeux de loin afin de qualifier la symétrie dans les 2 yeux. Une diminution du rouge rétinien doit faire penser à une opacification cornéenne ou un strabisme.

## 22.09.2021 – Médecine physique et réadaptation

**Physiothérapie** : elle permet de redonner les informations sensorielles notamment via la stimulation cutanée et l'accompagnement des mouvements chez les patients avec une plégie. Chez les patients avec hémisyndrome, la position du tronc est très importante en position assise ou en décubitus ; l'axe du tronc doit être respecté et pour se faire, il est nécessaire de surélever le bras plégique et de caler le pied sur le fauteuil. Les stimulations sensorielles répétées ainsi que la participation aux mouvements

La surélévation du membre supérieur permet également de prévenir une diasthase de l'épaule, c'est-à-dire lorsque l'humérus "tombe" car il n'est plus maintenu par le deltoïde et la coiffe des rotateurs.

Les muscles de la main n'étant plus fonctionnels, l'effet de pompe n'est plus assuré et un œdème de la main arrive rapidement. Pour le prévenir, il faut bander les doigts et la main ainsi que placer l'avant-bras en léger déclive.

**Neuropsychologie** : après un AVC, les atteintes peuvent être plus ou moins importantes sur le plan cognitif, praxique et phasique. De la même manière, les évolutions peuvent être plus ou moins rapides. Le travail des neuropsychologues se base sur l'atteinte cognitive du patient, en parallèle aux physiothérapeutes qui s'occupent de l'aspect moteur et les ergothérapeutes pour l'aspect environnement (vie quotidienne ; cuisine, se laver, ...).

Les jeux comme le Tabou sont utilisés pour évaluer et améliorer l'aphasie et le développement de stratégies. Des exercices plus ciblés sont également utilisés :

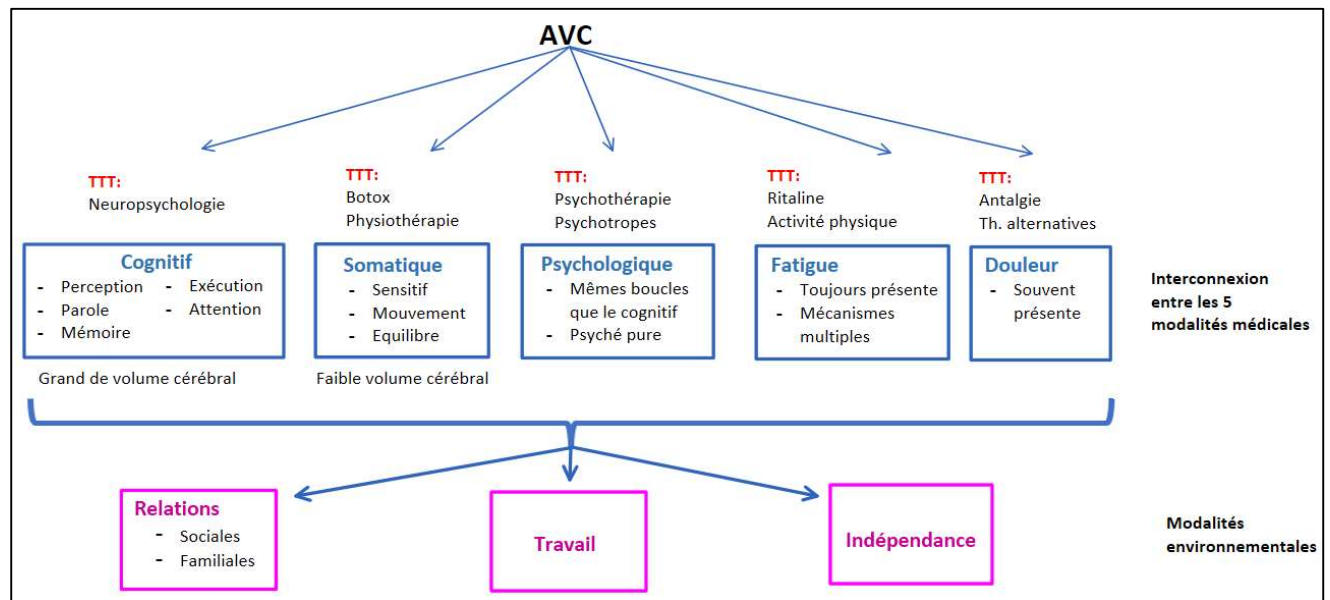
- Colonne de nombre, réaliser alternativement une addition / soustraction de 7 dans une colonne voisine
- Dans l'ordre alphabétique, nommer en alternance un prénom et un animal

Ces exercices permettent également de contrôler l'inhibition, qui peut être fortement diminuée après un accident vasculaire (par ex. : le patient commence l'exercice avant que la consigne soit terminée).

Le calcul est plutôt présent dans l'hémisphère pariétal gauche alors que l'écriture à droite. Un patient avec un AVC droit aura alors aucune peine à calculer mais les réponses ne seront pas bien alignées sur la feuille).

Lors de l'évaluation d'un RàD, il est nécessaire d'évaluer si à la maison il y a un accès facile (ascenseur, main courante), à évaluer avec les physiothérapeutes. De plus, il faut questionner sur les proches aidant (conjoint, famille, amis, voisins). Les buts du patients doivent être discutés et mis en lien avec les ATCD psychiatriques (anxiété, problèmes familiaux, volonté) car la présence d'une dépression ou d'une consultation psychiatrique précédente peut limiter les progrès et le pronostic d'un RàD.

## Implication d'un AVC dans la vie d'un patient



**Impact médical** : les 5 modalités "médicales" sont interconnectées entre elles, nécessitant une prise en charge globale, avec des thérapeutiques efficaces sur les différents thèmes. Hormis les modalités classiques que sont le cognitif, le somatique et le psychologiques, il est nécessaire de considérer la fatigue et les douleurs comme des entités à part entière puisqu'elles sont toujours présentes et donc qu'il est nécessaire de les prendre en charge en parallèle aux autres.

Les mécanismes de la fatigue sont nombreux :

- Anatomique (implication du striatum)
- Biologique (désordre sérotoninergique et dopaminergique)
- Fonctionnement psychique
- Habitudes de fonctionnement (interne vs externe ou fataliste)

**Impact environnemental** : il découle directement des modalités médicales mais influencent également ces dernières (cercle vicieux / vertueux). Il existe trois grandes catégories notamment le travail et la réinsertion professionnelle, les relations sociales et familiales et l'indépendance de la personne.

Par exemple, les patients peuvent se sentir si fatigués qu'ils n'arrivent plus à supporter de sortir en public et donc les relations sociales s'amouindrissent, causant de la déprime (cercle vicieux). Traiter efficacement les douleurs permet de réduire l'épuisement et donc de retrouver une certaine indépendance et une volonté de travailler durant le processus de réadaptation.

Les ruptures / divorces sont également beaucoup plus importants chez ces patients, notamment à moins de 50 ans à cause des changements de personnalité. Il en va de même avec les enfants.

**Accompagnement** : durant tout le processus, le patient doit se questionner sur ses buts et le sens des choses et de sa vie. Cet aspect est de l'ordre de la philosophie, qui est fondamentale pour que le patient puisse retrouver des perspectives durant la réadaptation. Cet accompagnement peut passer par la spiritualité ou via des philosophes sous forme de lecture, de conférences, etc. Le thérapeute doit inciter le patient à se poser ces questions.

## 29.09.2021 – Sédiment urinaire

**Maladie rénale chronique** : elle est caractérisée par une altération chronique des urines, des cellules rénales et par la présence possible d'une hématurie et/ou d'une protéinurie.

**Insuffisance rénale chronique** : elle est une altération chronique de la fonction rénale, décrite par la diminution du débit de filtration.

Il ne faut pas confondre ces deux entités puisqu'un patient avec une maladie rénale chronique peut conserver sa fonction rénale. Pour déterminer une pathologie ou une insuffisance chronique, il faut que l'atteinte dure depuis au moins trois mois.

**Fonction rénale** : elle est déterminée par la clairance rénale. En clinique, 2 méthodes permettent de l'évaluer :

1. Récolte urinaire sur 24h. C'est une mesure quantitative de la clairance rénale qui n'est plus réalisée car comporte de nombreux biais, notamment lors de l'échantillonnage par le patient. Cette technique est utilisée uniquement dans les bilans de maladies lithiasiques. La récolte commence à la 2<sup>ème</sup> miction de la journée, et se termine avec la 1<sup>ère</sup> miction le lendemain matin.
2. Formule de Cockcroft. C'est une estimation de la clairance via une équation prenant en compte la concentration sanguine de créatinine ainsi que le sexe et l'âge :  
$$Cl = \left( \frac{(140 - \text{âge}) * \text{poids}}{\text{Créat.sang}} \right) / 0.44$$
 on multiplie le résultat par 85% pour avoir la valeur chez la femme car la production de créatinine par l'organisme est moindre.

⚠ la créatinine surestime la clairance car la molécule est à la fois filtrée et sécrétée. Plus la fonction rénale diminue, plus la formule de Cockcroft surestime la clairance. ⚠

**Débit de filtration glomérulaire** : il est estimé via deux formules :

1. MDRD : elle est validée pour les patients entre 18 et 70 ans
2. CDK-EPI : elle est plus précise que celle du MDRD et devrait être utilisée de manière routinière. Elle tient également compte de l'ethnie.

La grosse différence entre la clairance et le débit de filtration glomérulaire est le rapport à la surface corporelle. En effet, la clairance est un débit simple [norme à >120 ml/min] alors que le débit de filtration glomérulaire se rapporte à la surface corporelle moyenne d'un adulte [norme à >60 ml/min/1.73m<sup>2</sup>].

**Fraction d'excrétion** : elle permet de déterminer quelle est la proportion d'une substance excrétée par le rein comparé à sa proportion sanguine :  $100 * \left( \frac{[x] \text{ urinaire}}{[x] \text{ plasmatique}} * \frac{[\text{Créat}] \text{ plasmatique}}{[\text{Créat}] \text{ urinaire}} \right)$

La fraction d'excrétion de l'urée est intéressante pour déterminer le différentiel d'une IRA:

<35% → insuffisance prérénale      >35% → insuffisance rénale

**Analyse d'urine – aspect et stix** : l'urine doit avoir un aspect limpide. Une urine trouble peut être causée par la présence de cellules, de germes ou de cristaux (diagnostic différentiel). Une urine qui mousse indique une albuminurie prononcée. Le stix est un bon examen de dépistage puisqu'il a une grande sensibilité et une valeur prédictive négative importante (= bonne capacité de détecter les malades, et bonne capacité qu'un sujet négatif soit effectivement sain). Il comprend 10 spot de test.

1. Densité : elle détermine la concentration des solutés en fonction de leur masse et non pas de leur nombre comme l'osmolarité. La valeur de référence est l'eau distillée. Une densité urinaire à 1.005 indique des urines diluées. Une densité à 1.020 voire 1.030 indique des urines concentrées et donc que le rein a conservé sa capacité à concentrer les urines. A contrario,

une densité inférieure à 1.003 peut indiquer un problème rénal ou une consommation d'eau excessive

2. pH : il peut être un révélateur de l'alimentation (végétarienne = alcalin) ou de pathologies. Par exemple, un pH bas aura tendance à favoriser l'apparition des lithiases d'acide urique. L'acidurie paradoxale est causée par des vomissements incoercibles ; ils entraînent une hypovolémie compensée par le rein par une réabsorption massive de sodium, qui se fait au détriment d'une sécrétion accrue de proton.

En plus de l'alimentation, le pH alcalin peut être signe d'infection. Les bactéries Gram négatives dégradent le nitrate en nitrites, qui est alcalin.

3. Corps cétoniques : ils indiquent que le corps ne dispose pas assez de glucides pour subvenir aux besoins énergétiques et qu'il a adopté un métabolisme à partir des lipides.
4. Glucose : des croix de glucose sont présents dans le diabète décompensé. Tout comme les corps cétoniques, il a un intérêt minime en néphrologie.
5. Protéines : le stix décèle uniquement l'albumine. Lorsque l'on veut qualifier une atteinte d'organe précoce chez le patient diabétique, qui se manifeste par une micro-albuminurie, il est nécessaire d'utiliser des bandelettes spécifiques beaucoup plus sensibles. Les bandelettes standards ne sont pas fiables en dessous de 300mg/L.  
On parle de protéinurie sélective si >80% des protéines contenues dans l'urine est de l'albumine. Sinon, on retrouve des chaînes légères d'immunoglobulines (→ protéinurie d'overflow, soit d'excès de fabrication) ou des petites protéines tubulaires.  
On réalise un dosage chez les patients avec diabète ou hypertension artérielle.
6. Urobilinogène : elle est le fruit de la dégradation de la bilirubine soit un marqueur de la dégradation de l'hémoglobine.
7. Leucocytes : ils peuvent indiquer plusieurs choses, qu'il faut mettre en évidence avec la clinique. La leucocyturie stérile peut indiquer une infection par des germes non cultivables comme les Chlamydias ou les Mycoplasmas. On considère en général trois grandes catégories de pathologies dans le diagnostic différentiel :
  - Contamination
  - Infection
  - Inflammation (tumeurs, lithiases, néphropathies)

Le sédiment urinaire peut apporter plus de précisions car si les leucocytes ont une disposition en cylindres, c'est-à-dire encapsulés dans des protéines tubulaires, ils seront d'origine rénale. Sinon, l'origine se situe dans l'arbre urinaire.

8. Nitrites : c'est un test qui est très spécifique et peu sensible comparé au reste de la bandelette. Ils sont un marqueur du métabolisme des bactéries Gram négatives, pour autant qu'elles soient restées un certain temps dans la vessie (en général 3h au moins).

9. Sang / hémoglobine : le test est très sensible, et permet de faire la distinction entre des érythrocytes entiers ou de l'hémoglobine. La bandelette agit sur la base d'une réaction de peroxydation, qui peut avoir :

- Faux positif en cas de présence de myoglobine (effort physique important, rhabdomyolyse)
- Faux négatif en cas de présence d'antioxydants comme la vitamine C

L'hématurie doit être mise en lien avec un contexte clinique, puis doit être classée comme isolée ou non. Un sédiment urinaire permet d'observer les érythrocytes au microscope pour déterminer s'ils ont une origine glomérulaire (érythrocytes fortement déformés) ou une origine de l'arbre urinaire (infection, tumeur, lésion → cystoscopie). Parfois, les 2 atteintes peuvent être conjointes.

Parmi les différentes morphologies, les acanthocytes (image) sont très spécifiques d'une atteinte glomérulaire. Ils sont formés par une force d'abord mécanique qui est le passage dans le filtre glomérulaire, puis une force hydrodynamique qui sont les différentes pressions osmotiques dans le système de contre-courant des tubules (300mOsm → 1200mOsm → 300mOsm).



Il est préférable de réaliser un sédiment urinaire sur les urines du matin pour éviter que l'osmolarité ne soit trop basse et qu'elle fasse éclater les érythrocytes par osmose. De plus, il faut que l'examen soit réalisé rapidement après le prélèvement car les érythrocytes ont tendance à hémolyser rapidement tout seuls.

### 13.10.2021 – Neurologie

#### **Cas clinique discuté pendant le Grand Round :**

1) Dans quel syndrome les signes peuvent-ils être regroupés ?

Syndromes amnésique et comportemental (troubles de la mémoire, dépenses inadaptées au budget, remarques inadaptées) associé à une dépression et un burnout lié à une inadaptation au COVID.

ATCD familiaux : bcp d'épisodes dépressifs, trbls cognitifs mnésiques en fin de vie.

Examen clinique : anosognosique, parole et vision OK, status neuro OK. MMS 24/30, mauvaise position aiguilles test horloge. Troubles de la mémoire épisodique verbale en encodage et récupération et visuospatiale

#### Diagnostic 3D :

1. Stade clinico-fonctionnel : trbls neurocognitifs mineurs (association d'une plainte et des anomalies de tests → la plainte peut provenir de l'hétéroanamnèse)
2. Phénotype : hippocampique (mnésique temporal interne)
3. Etiologie : neurodégénératif → MA ou DFT

PEC : bilan neuropsych. Anosognosie importante, distractibilité, ralentie mais orientée, signes de fatigabilité. Déficitaire pour rappeler des mots, également quand on lui donne des indices.

Examens complémentaires : IRM cérébral qui montre une atrophie frontale et insulaire D, hippocampique discrète. Asymétrie des zones sous-corticales à la pointe ventriculaire

On complète avec un PET-FDG qui montre un hypométabolisme frontal D.

On veut faire une PL mais à cause des malaises vagues on s'oriente sur un PET amyloïde qui est normal et parle contre une maladie d'Alzheimer.



Evolution en une année à un trouble neurocognitif majeur, grosse perte de fonction. On refait un bilan neuropsychologique d'évolution qui montre une persistance du trouble verbal mais la tâche visuospatiale est sévèrement déficitaire. Les reconnaissances d'émotions sont inférieures à la moyenne.

Diagnostic : DFT. On commence par éliminer les marqueurs d'une MA, puis on évalue la variante de DFT qui est ici comportementale. Ensuite, on dose la progranuline 2x et si elle est abaissée, on cherche une mutation du gène C9 et de la PGRN. Une mutation est trouvée mais on ne sait pas si elle est pathogène. Il existe plusieurs formes de DFT qui sont associées à des scores mais également à des atrophies spécifiques à l'IRM.

La DFT est complexe car il faut matcher des données cliniques, neuropathologiques et génétiques. La plupart du temps un syndrome hippocampique est une MA. Ces critères ne matchent pourtant pas toujours. Pour la DFT, le tableau clinique est souvent peu clair entre les différentes formes.

2. Quelle localisation anatomique explique l'atteinte des différents syndromes ?  
Lobe frontal / temporal
3. Vu la localisation et le contexte, quel est le diagnostic différentiel le plus probable ?

Maladie d'Alzheimer, démence fronto-temporale

### **Les démences**

Le médecin, l'entourage ou le patient lui-même peut rapporter des plaintes. Le patient est souvent anosognosique et donc il est utile de favoriser l'hétéroanamnèse. Le diagnostic est nécessaire même sans plainte du patient pour pouvoir :

- Adapter la vie du patient (logement, travail, activités, entourage)
- Planning familial en cas de troubles génétiques

Pour déclencher la MA, il faut à la fois une maladie amyloïde (les dépôts peuvent être très importants sans symptômes) et une maladie Tau, qui sont des stabilisateurs de microtubules. Lorsque ces derniers sont phosphorylés, ils ne stabilisent plus et les microtubules s'effondrent causant la mort des neurones.

La DFT a une évolution rapide, avec un décès en général dans les 6 ans, surtout comparé à la MA. De plus, le diagnostic se pose plus jeune. Lors de la DFT, en général c'est l'aspect frontal qui prédomine comme premiers symptômes. Ensuite, quelle que soit la pathologie, la démence touche tout le SNC et les patients deviennent grabataires et décèdent.

Lorsque l'on a une démence, on doit les classer selon trois axes (diagnostic 3D) :

1. Stade : c'est l'impact sur l'autonomie. Il se décrit en un stade de trouble neurocognitif mineur (pas d'impact sur l'autonomie) ou majeur (impact important)
2. Phénotype clinique : quelle est la structure qui est touchée selon les symptômes prédominant. C'est le bilan neuropsychologique qui permet de le déterminer
3. Physiopathologie : quelle est la maladie sous-jacente

Devant une démence, il faut regarder dans un premier temps s'il y a une atteinte neurodégénérative ou une cause traitable car même si elles sont rares, elles peuvent être traitées :

- Toxique (OH, déficit en B12)
- Encéphalopathies de Gayet-Wernicke qui peut se décompenser en Korsakoff, c'est un déficit en B1.
- Encéphalopathie hépatique
- Méningiome
- Hématome sous dural chronique
- Infections par syphilis, Lyme, HIV

→ suivre l'algorithme VINDICATE pour stratifier les différentiels traitables

Pour exclure ces causes, on réalise un IRM et un bilan sanguin, voire une PL. Dans la MA, on a un dépôt de b-amyloïde et de protéines Tau. Les dépôts se forment dans un premier temps dans le système hippocampique, avec donc des problèmes de mémoire en premier plan. Elle s'étend ensuite dans les zones de la parole, de la vue puis partout.

Dans les DFT, la protéine qui se dépose est également une Tau. Le dépôt se fait dans le lobe frontal qui est responsable de la fonction exécutive (3 axes : planification, motivation, normes sociales).

La maladie de Parkinson fait une atteinte cognitive mais plutôt tardive, expliqué par le parcours de l'a-synucléine qui fait un dépôt de corps de Lewy dans le nerf olfactif, le SNA et finalement la substance noire. Les premiers troubles sont donc souvent les pertes d'odorat et de goût, puis des troubles vasomoteurs mais en général ils ne motivent pas une consultation. Ensuite, les troubles moteurs apparaissent et comme c'est très handicapant on les voit en consultation. Les traitements de dopamine permettent de bien traiter ceci pendant longtemps puis la maladie progresse dans le tronc cérébral et finalement dans le cortex créant les troubles cognitifs.

La maladie à corps de Lewy (LBD) prend la même logique avec un dépôt d'a-synucléine et d'ubiquitine comme dans la MPk. La différence est que le dépôt commence également dans le nerf olfactif faisant ce prodrome, puis se dépose à la fois dans le cortex et dans la substance noire, et non pas 20-30 ans plus tard comme la MPk. On doit donc penser à une LBD lorsque l'on a une apparition dans la même année des symptômes pyramidaux et cognitifs (orientation visuospatiale, organisation, hallucinations pour compenser le manque visuel).

La maladie de Creutzfeldt Jacob est également une démence qui touche de manière très diffuse et rapide le SNC.

La microangiopathie amyloïde est associée à la MA, qui est une forme d'a-amyloïde un peu différentes qui se dépose dans les vaisseaux de préférence et créent des saignements. En général, la MA est également diagnostiquée chez ces patients.

La démence vasculaire est la deuxième plus fréquente après la MA. Elle crée des micro-saignements dans l'ensemble du SNC, créant des problèmes diffus et donc les problèmes sont surtout causés par la

déconnexion du lobe frontal et donc un syndrome dysexécutif. Les lésions vasculaires sont bien visibles à l'IRM et on a une association en général avec une HTA associée.

Une démence très rapidement mortelle est l'ALS. C'est un dépôt de la protéine TDP qui se dépose dans les voies pyramidales (premier motoneurone) et dans le deuxième. En quelques années, il y a une perte de la musculature de l'ensemble de l'organisme y.c. ceux de la déglutition.

Cliniquement, ces maladies sont relativement caractéristiques. Le modèle en 3D permet d'avoir une bonne classification sans poser un diagnostic tout de suite pendant que l'on réalise les examens. Il permet également de ne pas recommencer à zéro en cas d'évolution du diagnostic puisque les impacts et le phénotype ont déjà été évalués. Pour le diagnostic, on utilise des biomarqueurs que l'on peut obtenir entre autres avec une ponction lombaire. Cependant, si le tableau clinique est évocateur, on arrive à déterminer le diagnostic directement. Faire des catégories est utile pour pouvoir mettre des médicaments en route et pour évaluer le pronostic.

### 13.10.2021 – Soins palliatifs

« Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychosociaux et spirituels. (selon OMS) ». La douleur est un ressenti localisé dans le corps (somatique) alors que la souffrance comporte une dimension psychique avec la réflexion et le rapport à soi. L'approche met le patient au centre et inclus les proches.

En soins palliatif, les prises en charge sont interdisciplinaires. Le rôle du médecin palliativiste est d'une part la pose de diagnostic mais surtout de faire une médecine très clinique sans vraiment d'examens complémentaires car ils ne font plus sens. Les traitements sont posés sur la base des hypothèses diagnostic précédemment posés. Les autres intervenants sont les infirmiers, les psychologues, les accompagnants spirituels et les assistants sociaux. Comme outil, les antidépresseurs sont très souvent utilisés.

Un partenaire peut également être Exit, qui sont sollicités par les patients. Les médecins ne prennent pas de responsabilité dans la prise en charge mais travaillent en parallèle en offrant un autre type d'accompagnement que le suicide assisté. Ceci permet montrer les autres alternatives, qui sont sur un plus long terme avec une vision d'accompagnement et de traitement de ce qui est traitable. Il faut des conditions spéciales pour qu'Exit intervienne dans les hôpitaux, cliniques ou EMS mais ils peuvent le faire. Les conditions passent par l'information de la direction médicale, une visite des soins palliatif et une évaluation de la capacité de discernement par une équipe psychiatrique. La démarche du suicide assisté par contre se fait sans l'équipe médico-soignante du patient, ce n'est que le personnel d'Exit qui s'en occupe. L'équipe peut revenir uniquement après l'évaluation du médecin légiste et de la police puisque le suicide est considéré comme une mort violente.

La maladie génère une rupture dans l'histoire de vie des patients et le rôle des psychologues / accompagnants spirituels est de remettre un sens. C'est donc la subjectivité du patient qui est au centre des décisions. Les patients doivent mettre des mots sur ce que la maladie implique pour eux et ce sont leurs récits qui permettent de réaliser la prise en charge adaptée. L'idée est de réinscrire la maladie dans l'histoire du patient, qu'il puisse l'accepter et s'adapter. Chez les patients très ouverts, on peut alors même aborder les sujets de ce qui se passe après le décès comme les obsèques ou l'autopsie. Souvent ils sont même très ouverts.

Lorsque l'on prend en charge un patient, il faut demander au patient quel est le point qui pèse le plus la qualité de vie. Comme ceci, on peut avancer pas par pas. Par exemple, un patient peut être somatiquement OK, psychologiquement OK mais par contre sur le plan spirituel et du sens de la vie ils ne savent plus à quoi sert leur vie. L'altruisme a une place importante car certains patients aiment

pouvoir aider. Ceci passe par exemple par la discussion avec les étudiants, ce qui permet de valoriser le patient. Pour améliorer la confiance entre le thérapeute et le patient, les patients peuvent être amenés à demander au médecin leur avis ou leurs croyances. Si les motivations derrière la question sont bonnes, il est intéressant d'avoir ces discussions. Une question type est « si c'était pour votre X, qu'est-ce que vous feriez ? ». On ne peut pas se mettre à leur place mais on peut amener les différentes options thérapeutiques et on éclaire le patient selon notre avis d'expert et pas de malade.

**Théorie de la perte :** la patientèle est très variée du point de vue de l'acceptation de la maladie. Des patients jeunes acceptent très bien leur maladie alors que des patients très âgés sont combatifs et en colère jusqu'à la fin. Le deuil est un processus entre le moment de l'annonce du diagnostic et le décès. Durant ce temps qui peut être plus ou moins long, un travail psychique doit se faire pour amener le patient à la mort. Le processus passe par la perte, qui peut être présente sur de nombreux plans :

- Autonomie
- Responsabilité
- Mobilité
- Changement de status social (ex. : passer de manager à personne aidée)
- Lien à l'autre (famille, enfants, collègues)
- Identité (fonction dans la société, perception de son corps et des sensations)

Le deuil est le processus qui permet de couper le lien d'attachement ou l'investissement consacré à l'objet perdu. Si le processus réussi, la potentialité d'investissement est conservée, c'est-à-dire que le patient peut remettre de l'énergie dans quelque chose d'autre qui fait sens pour lui. C'est un processus long et relativement difficile. Les étapes du deuil se mettent environ sur 36-24 mois mais peuvent mettre plus ou moins de temps. Ce qui distingue le physiologique du pathologique est la fonction car une personne qui est en deuil mais reste capable de vivre et de fonctionner en subvenant à ses propres besoins c'est un deuil physiologique.

**Rôle des proches :** parmi les proches aidants, on retrouve la famille mais également souvent les voisins. Parfois, ces personnes sont dans un état de santé physique ou psychique qui peut se péjorer et donc ont un risque de craquer. Ils deviennent alors des co-patients. Certaines fois, les proches peuvent même devenir des barrières pour les soins et prétendent la prise en charge. Les proches sont très souvent sollicités par les palliativistes puisque pour une partie des patients il y a une péjoration telle que la communication ne se fait qu'au travers des proches. On peut ainsi également demander aux patients de participer à l'évaluations notamment pour savoir si le patient est confortable. Ceci permet d'affiner la prise en charge mais également de renforcer le rôle du proche aidant. De manière générale, il y a plusieurs manières d'inclure les proches dans la prise en charge.

Il est important d'avoir une idée lorsqu'on suit un patient, de savoir qui dans son réseau social sont aidant. On peut ainsi veiller à eux pour qu'ils aient un soutien. Il faut également prendre soin de ces personnes, en évitant qu'ils s'épuisent notamment en vérifiant qu'ils puissent eux-mêmes consulter leur médecin traitant ou en parler avec des personnes. Une chose fréquente sur laquelle on peut avoir une bonne influence est la culpabilité des proches. Il faut proactivement dire aux proches que ce n'est par exemple pas à cause d'eux que le patient est hospitalisé mais plutôt grâce à eux que le patient est hospitalisé que maintenant. Leur offrir une présence et un temps d'écoute est des fois suffisant.

**Biais de genre en soins palliatif :** une étude de Temel a démontré sur une population de patients avec cancer pulmonaire avancés séparés en 2 groupes dont un avec soins palliatif. Avec les soins palliatifs, d'une part la qualité de vie augmente mais également la durée de vie, significativement de 6 semaines en moyenne. Il faut faire attention aux femmes proche aidantes car elles sont plus à risque d'avoir elles-mêmes des problèmes.

**Altruisme :** c'est une valeur importante chez les patients en fin de vie, qui prend de plus en plus d'importance.

**Spiritualité** : c'est une démarche cognitive de l'homme se caractérisant par la recherche d'un sens et d'un but pour son existence. Elle peut être fondée sur les croyances religieuses ou non, une attitude philosophique, morale, artistique ou scientifique. Elle fait partie du développement de l'homme. C'est quelque chose que l'on peut investiguer durant l'anamnèse avec le SPIR, qui permet de définir la personne comme une personne avec une spiritualité, quelle est l'importance dans la vie actuelle et/ou dans la maladie, l'intégration de la personne dans un groupe spirituel et finalement le rôle que le patient souhaite donner au praticien ou à quelqu'un d'autre vis-à-vis de cette spiritualité.

Un autre modèle est celui des besoins STIV : Sens, Transcendance, Identité, Valeurs. Lorsque l'on a une preuve que la spiritualité est importante pour le patient grâce au SPIR, on peut ensuite orienter les patients vers les accompagnants spirituels qui eux utilisent le SPIV.

En évaluant la spiritualité un peu en détail, on peut ainsi déterminer quels sont les valeurs importantes pour la personne.